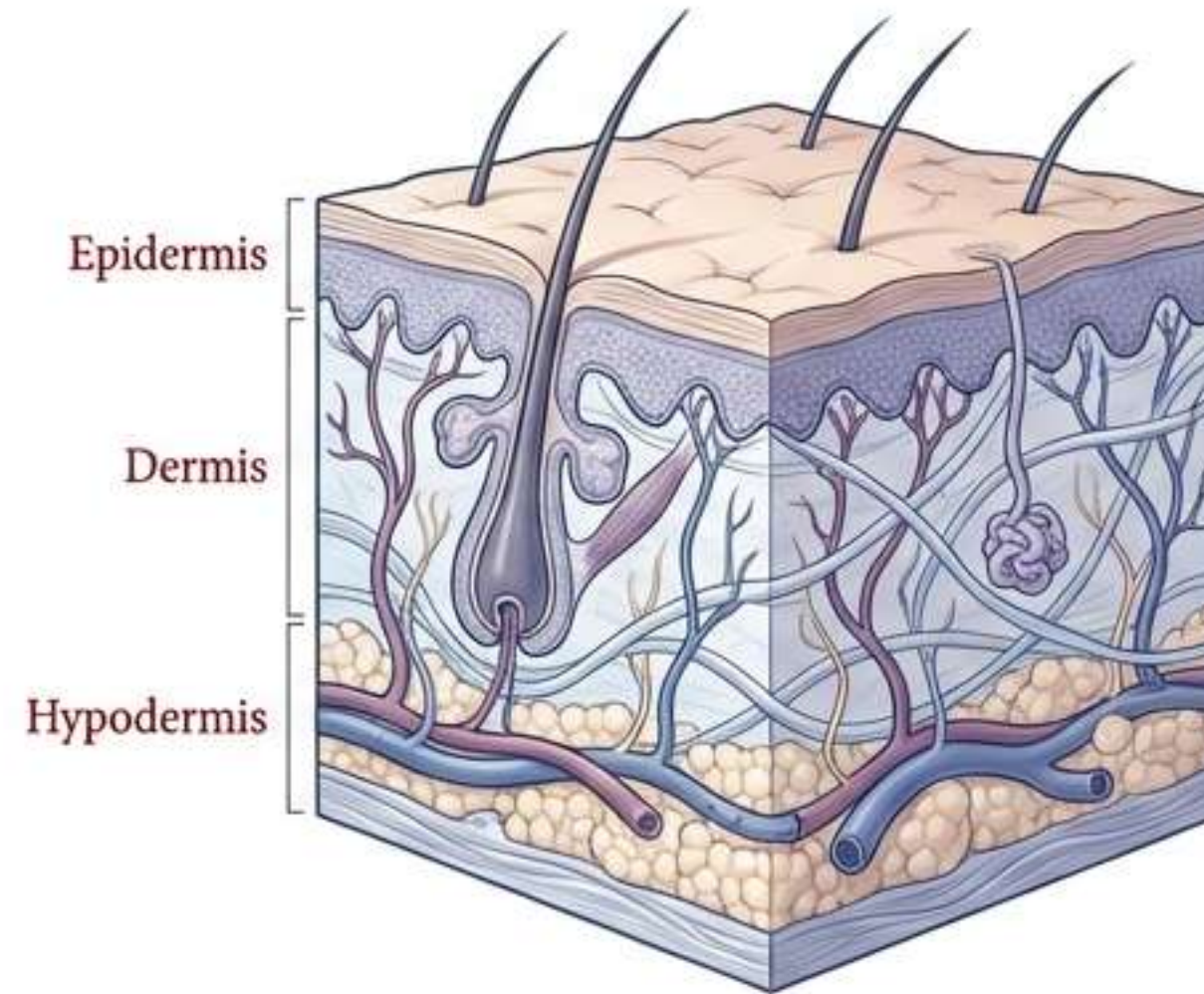


Tumeurs des Tissus Conjonctifs

Guide d'Étude & Préparation aux Examens



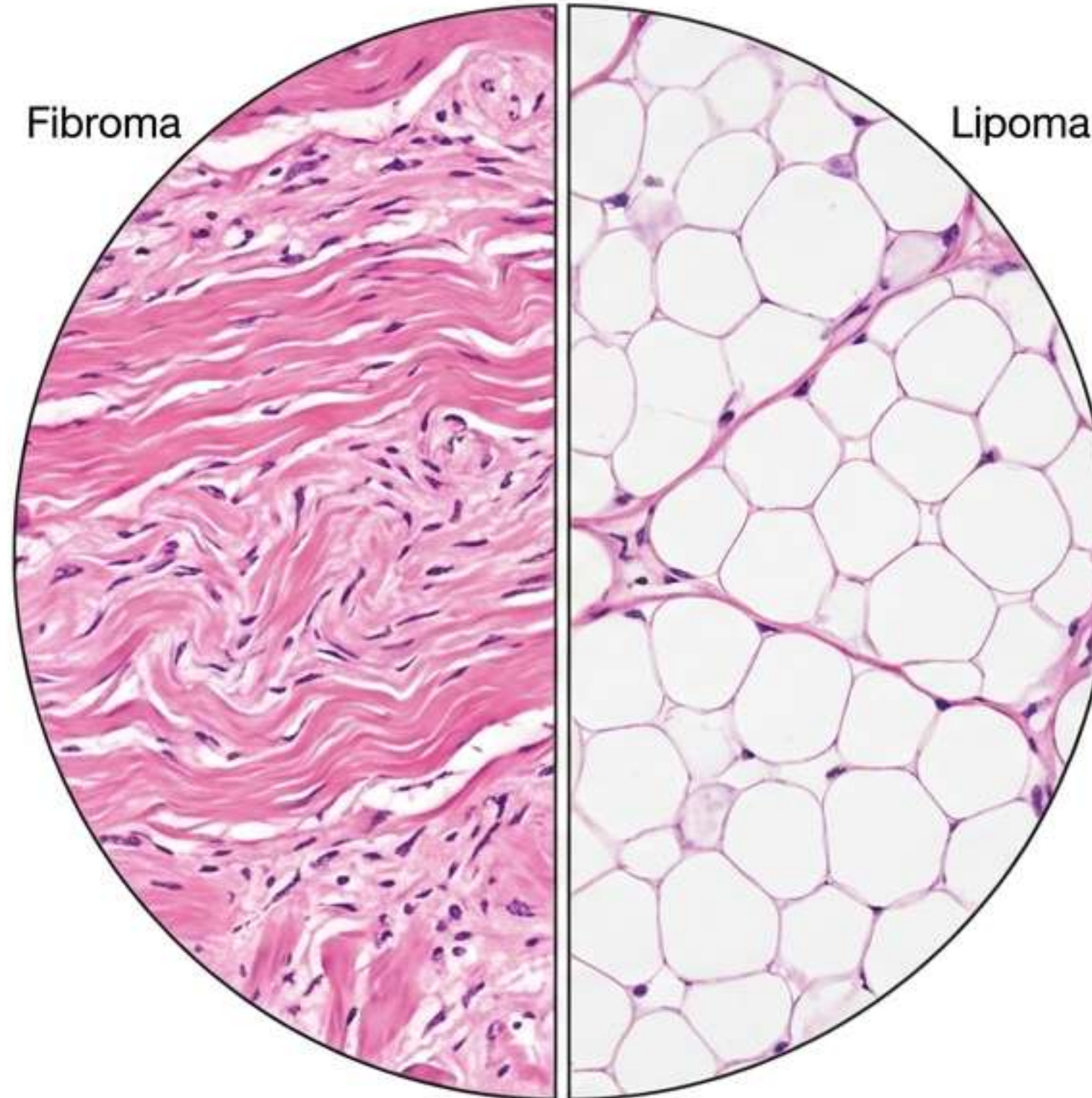
Plan du Cours :

1. Tumeurs Bénignes (Fibromes, Lipomes, Angiomes, Myomes, Chondromes, Ostéomes)
2. Tumeurs Malignes : Les Sarcomes (Généralités, Tissus Mous, Tissus Squelettiques)
3. Les Autres Tumeurs (Hémolymphatiques, Mélaniques, Système Nerveux)

1. Tumeurs Bénignes : Fibromes & Lipomes

A/ Les Fibromes

- **Définition** : Lésions nodulaires, bien circonscrites.
- **Localisation** : Siègent dans le derme, le chorion des muqueuses ou certains parenchymes.
- **Histologie** : Constitués d'un tissu conjonctif adulte, riche en collagène [Ref: Q2].



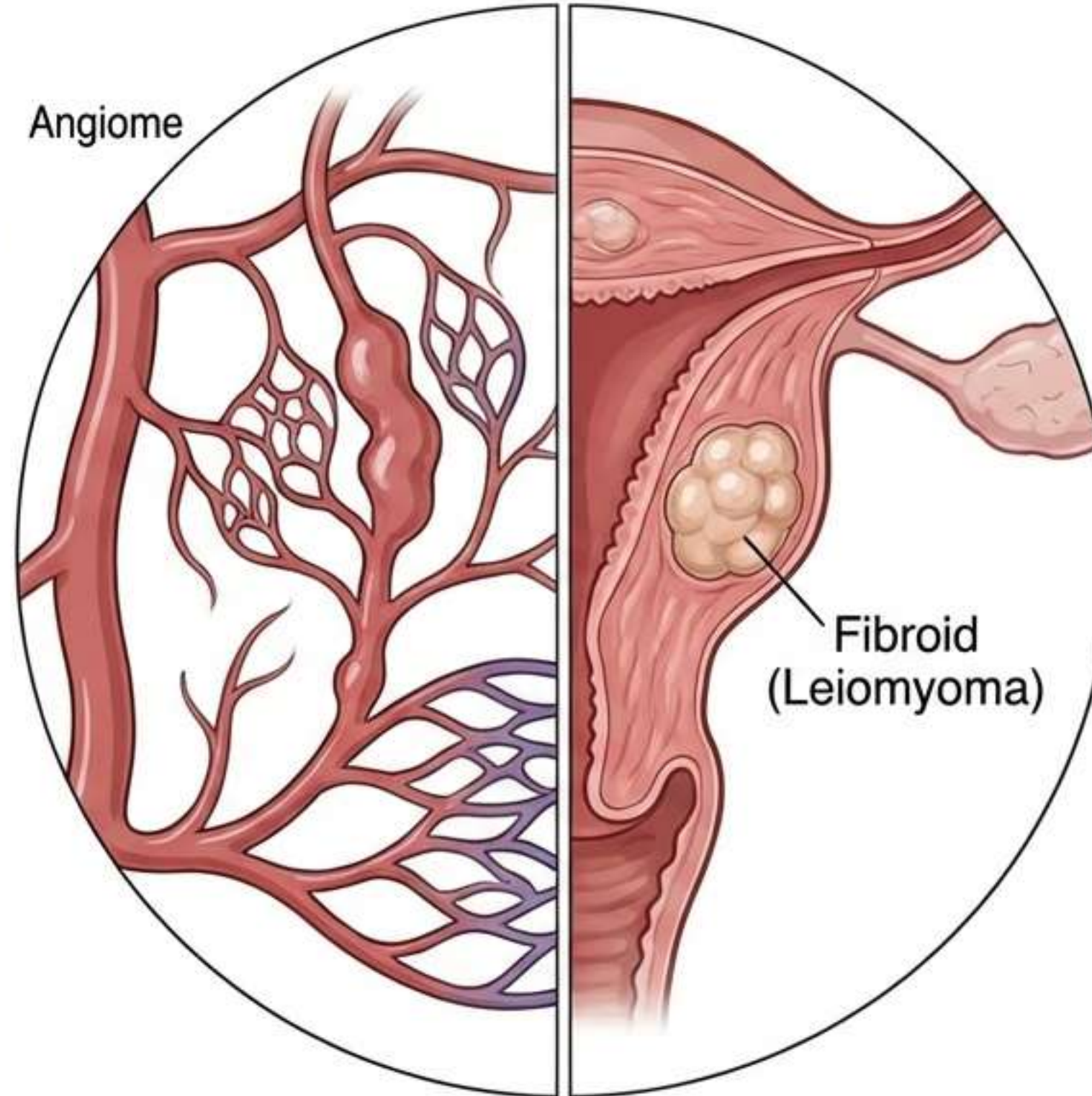
B/ Les Lipomes

- **Description** : Tumeurs généralement encapsulées, uniques ou multiples.
- **Composition** : Constitués de adipeuses matures groupées en lobules [Ref: Q4].
- **Associations** : Parfois associées à une composante fibreuse (fibrolipome) ou vasculaire (angiolipome).
- **Localisation** : Habituellement dans le tissu sous-cutané.

1. Tumeurs Bénignes : Angiomes & Myomes

C/ Les Angiomes

- **Nature** : Les angiomes ou lymphangiomes sont le plus souvent considérés comme des hamartomes et non comme des tumeurs [Ref : Q8].
- **Angiomatoses** : Lésions vasculaires multiples dans maladies congénitales (ex : Maladie de von Hippel-Lindau).



D/ Les Myomes (Tumeurs musculaires)

1. Léiomyomes (Muscle Lisse)

- **Fréquence** : Fréquentes.
- **Aspect** : Bien circonscrites, parfois volumineuses.
- **Localisation** : Utérus (improprement appelés « fibromes musculaires digestives, derme [Ref : Q13].

2. Rhabdomyomes (Muscle Strié)

- **Fréquence** : Exceptionnelles.
- **Classification** : Tumeur bénigne du muscle strié [Ref : Q3].
- **Exemple** : Rhabdomyome cardiaque de la sclérose tubéreuse de Bourneville.

1. Tumeurs Bénignes : Chondromes & Ostéomes

E/ Les Chondromes

- **Définition :** Tumeurs nodulaires faites de tissu cartilagineux bien différencié [Ref: Q11].
- **Localisation :** Surtout petits os des mains et des pieds.
- **Pathologie :** Maladie de Ollier = Chondromatose (multiples chondromes).



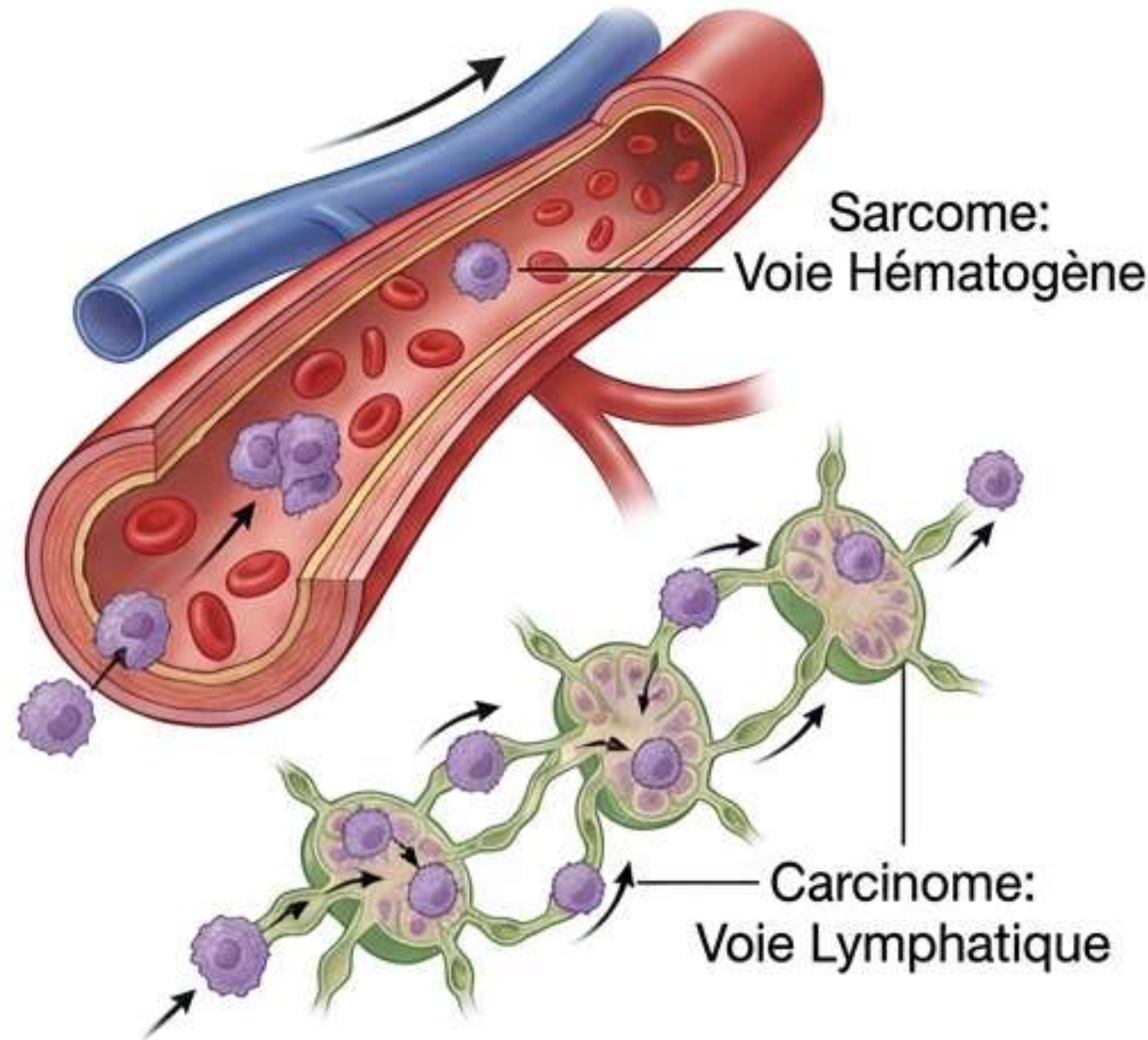
F/ Les Ostéomes

- **Définition :** Lésions rares, constituées d'os mature.
- **Localisation :** Essentiellement les os de la face.
- **Note :** Leur nature tumorale est discutée.

2. Les Sarcomes : Définition & Caractères Généraux

A/ Définition

- Les sarcomes sont des proliférations malignes dont les cellules ressemblent à celles des tissus conjonctifs [Ref: Q1].
- Origine : Fibroblastes du tissu conjonctif commun ou cellules des tissus conjonctifs spécialisés.



B/ Caractères Généraux

- Fréquence : Beaucoup plus rares que les carcinomes.
- Évolution : Développement très rapide, évolution spontanée défavorable [Ref: Q7].
- Extension : Loco-régionale rapide avec compression.
- Métastases : Fréquence des métastases hématogènes [Ref: Q14].
- Nomenclature : Suffixe « -sarcome » = Malin.
- Classification : Classification OMS 2020 basée sur le type de tissu REPRODUIT par la tumeur et non l'histogenèse.

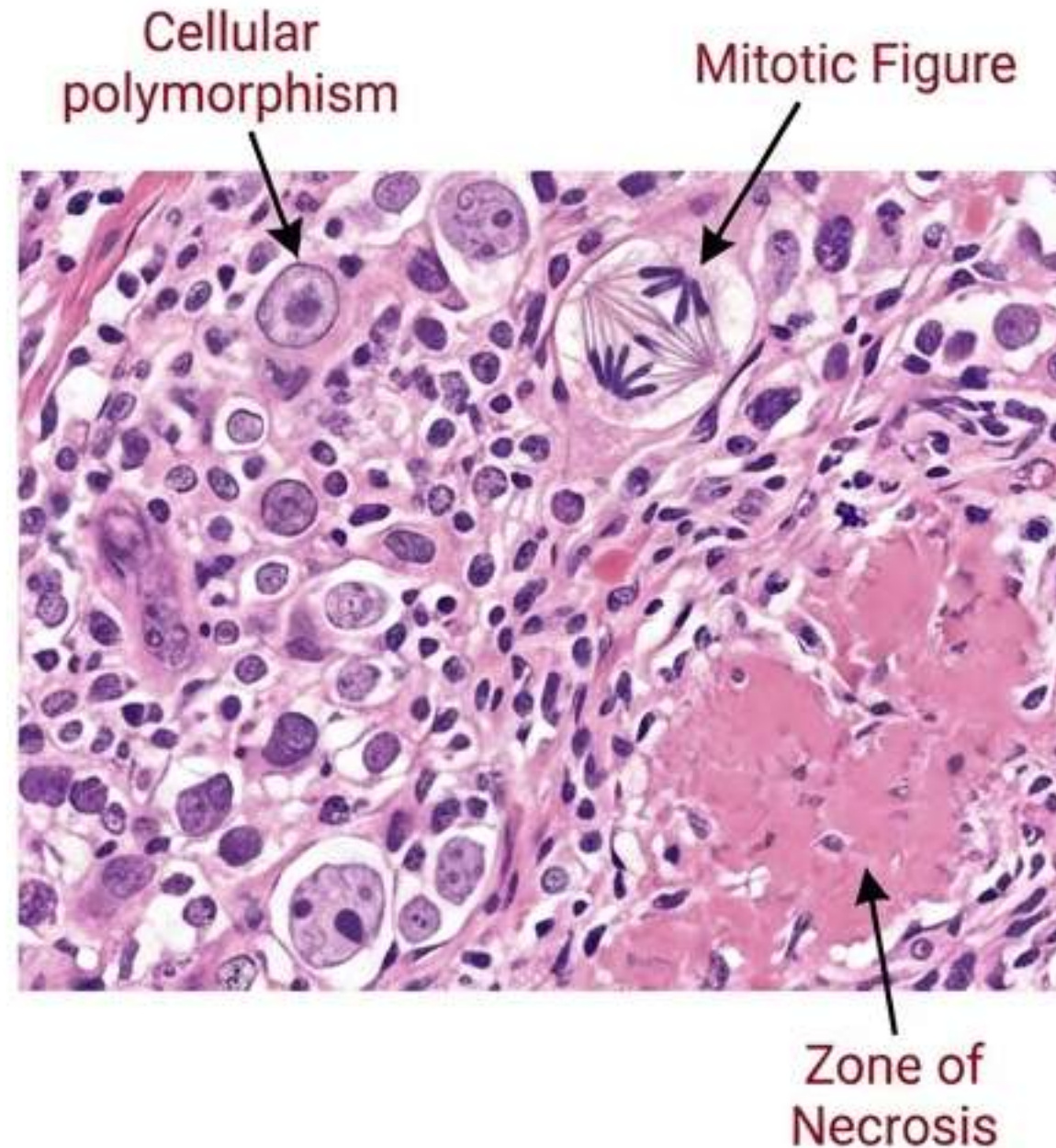
2. Les Sarcomes : Morphologie & Diagnostic

C/ Aspects Macroscopiques

- **Type 1** : Tissu blanchâtre, mou, « encéphaloïde », infiltrant et détruisant.
- **Type 2** : Masse ferme, contours polycycliques, refoulant les tissus.

D/ Aspects Microscopiques & Grading

- **Caractéristiques** : Grand polymorphisme.
- **Grading** : Basé sur la différenciation, le nombre de mitoses, et la présence de nécrose.



Difficultés Diagnostiques

- **Sarcomes très bien différenciés** : Difficile d'affirmer la malignité (ex: liposarcomes, chondrosarcomes). Confrontation anatomo-radio-clinique essentielle.
- **Sarcomes indifférenciés** : Difficile d'affirmer le type tumoral. Nécessite IHC, ME, Cytogénétique, Bio Moléculaire.
- **Classification Pratique** : Sarcomes des tissus mous vs. Sarcomes des tissus squelettiques.

I. Sarcomes des Tissus Mous (1/3)



Liposarcome



Rhabdomyosarcome

1. Liposarcomes

- **Définition** : Tumeur maligne développée à partir du tissu adipeux [Ref: Q15].
- **Localisation** : Ubiquitaires (Membres, espace rétropéritonéal, rarement cavité buccale).
- **Histologie** : Variable, de peu différencié (rares lipoblastes) à très bien différencié (proche du lipome).
- **Évolution** : Récidives locales et métastases.

2. Rhabdomyosarcomes

- **Définition** : Tumeur maligne du muscle strié [Ref: Q10].
- **Forme Adulte** : Dans le muscle strié. Prolifération fusiforme à différenciation musculaire (double striation). Évolution courte, métastases précoces.
- **Forme Embryonnaire (Enfant)** : Ubiquitaire (hors des muscles striés).
- **Types Histologiques** : Botryoïde, Alvéolaire, Embryonnaire (pronostics différents).

I. Sarcomes des Tissus Mous (2/3)

3. Léiomyosarcomes

- **Définition :** Tumeur maligne du muscle lisse [Ref: Q5].
- **Localisations :** Derme, utérus, tube digestif.
- **Histologie :** Prolifération fasciculée de cellules fusiformes à différenciation musculaire lisse.



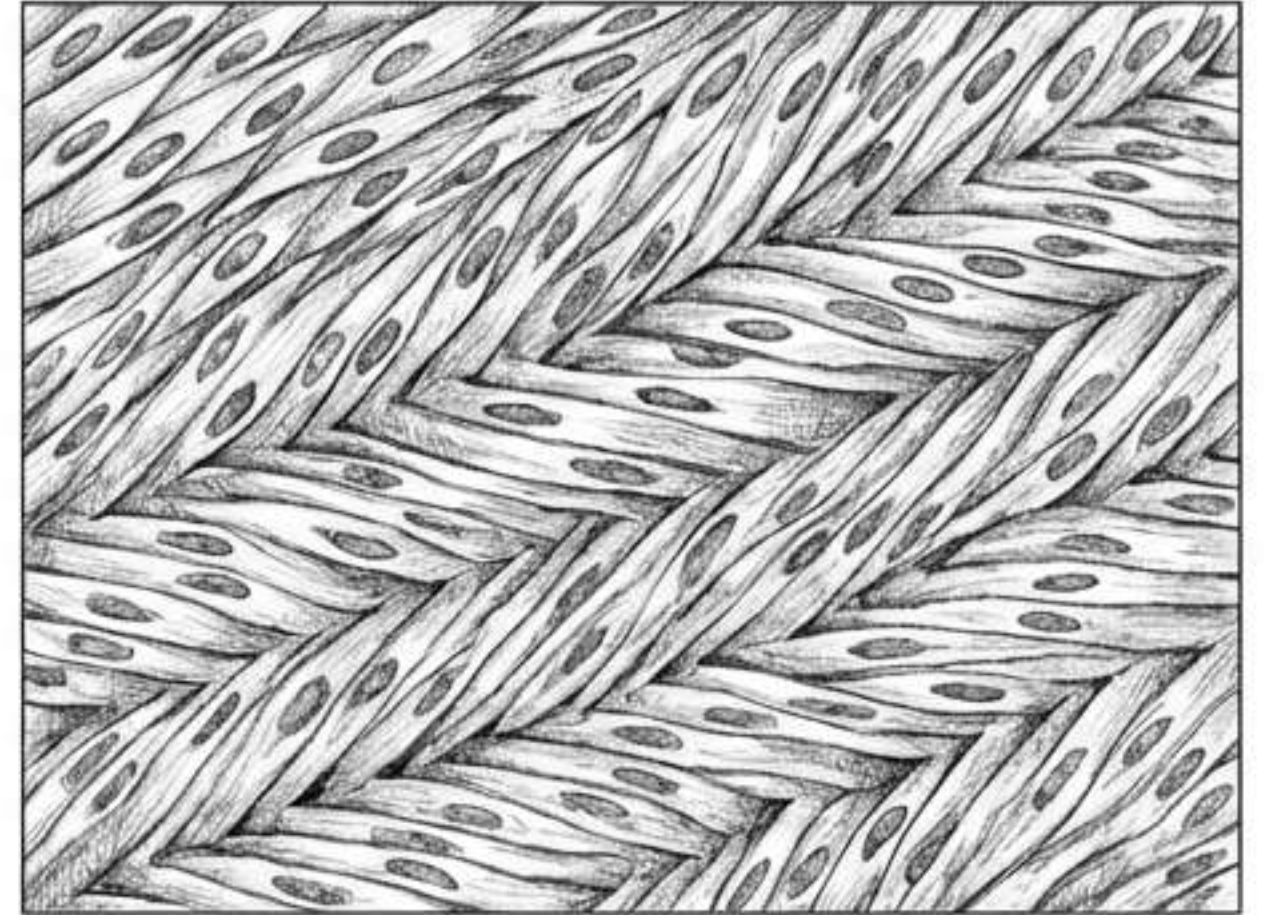
4. Angiosarcomes

- **Définition :** Tumeur maligne de l'endothélium vasculaire [Ref: Q12].
- **Morphologie :** Aspects très variés.
- **Évolution :** Dissémination métastatique + Hémorragies massives.
- **Forme Spécifique :** Sarcome de Kaposi (fréquent au cours du SIDA).

I. Sarcomes des Tissus Mous (3/3)

5. Fibrosarcomes

- **Définition** : Prolifération maligne de fibroblastes [Ref: Q9].
- **Aspect** : Ubiquitaire. Tumeur fasciculée.
- **Histologie** : Cellules fusiformes disposées dans des fibres collagènes (architecture fasciculée).
- **Évolution** : Récidives locales et métastases hématogènes.



Fibrosarcome

Diagnostic Différentiel

- **Note** : Un certain nombre de proliférations morphologiquement proches des fibrosarcomes présentent une évolution tout à fait différente.

II. Sarcomes des Tissus Squelettiques (1/2)

1. Sarcomes Ostéogéniques (Ostéosarcomes)

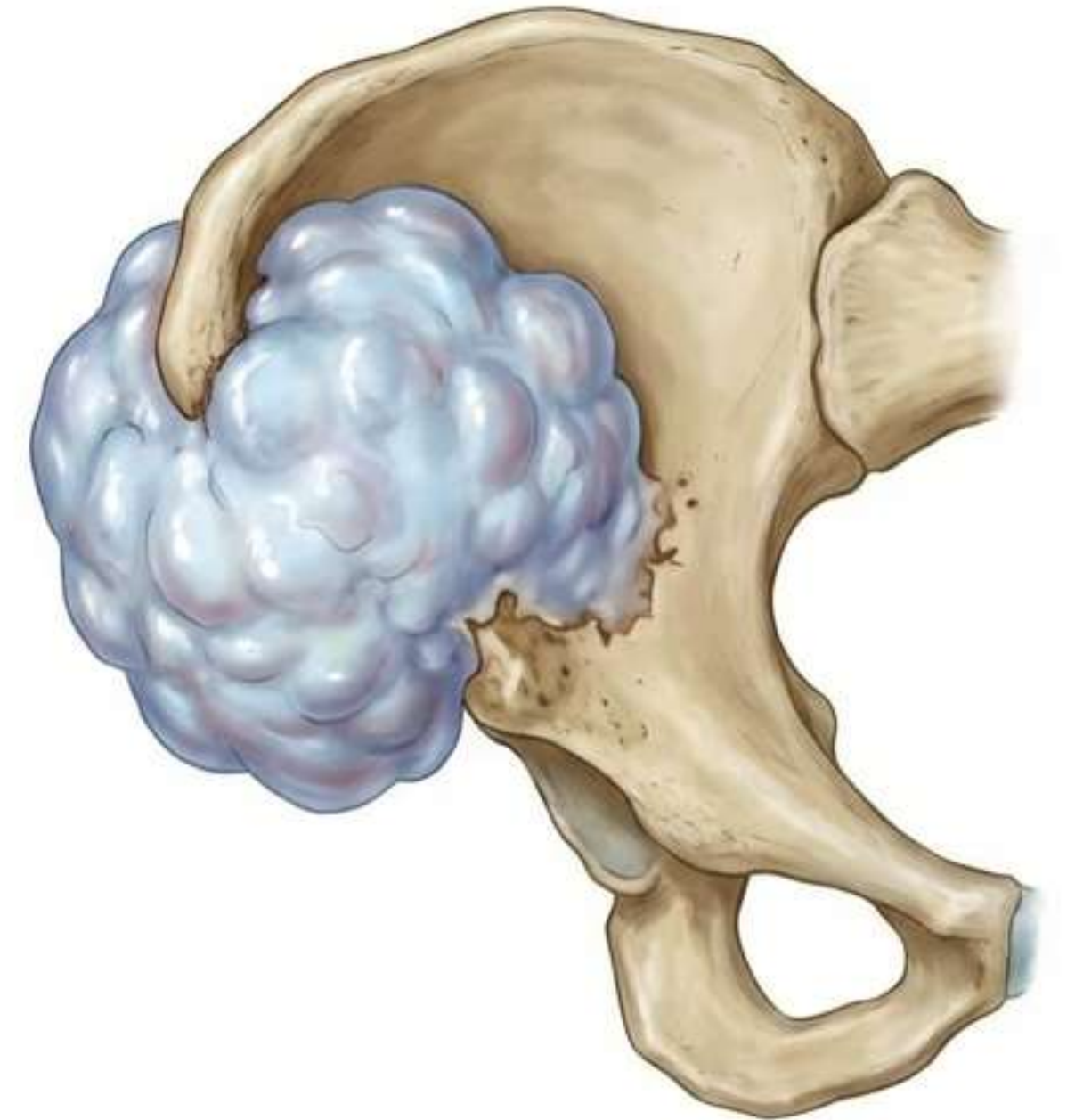
- **Définition :** Tumeur maligne primitive la plus fréquente du tissu osseux [Ref: Q6 context].
- **Macroscopie :** Tumeur métaphysaire (Fémur, Tibia, Humérus, Maxillaires).
- **Progression :** Détruit la corticale, dépasse le périoste, envahit parties molles.
- **Radiologie :** Aspect en « feu d'herbe » (Sunburst).
- **Histologie :** Prolifération fusiforme parsemée de foyers d'ostéogenèse tumorale.
- **Évolution :** Rapide. Douleurs, fractures spontanées, métastases (Poumon).



II. Sarcomes des Tissus Squelettiques (2/2)

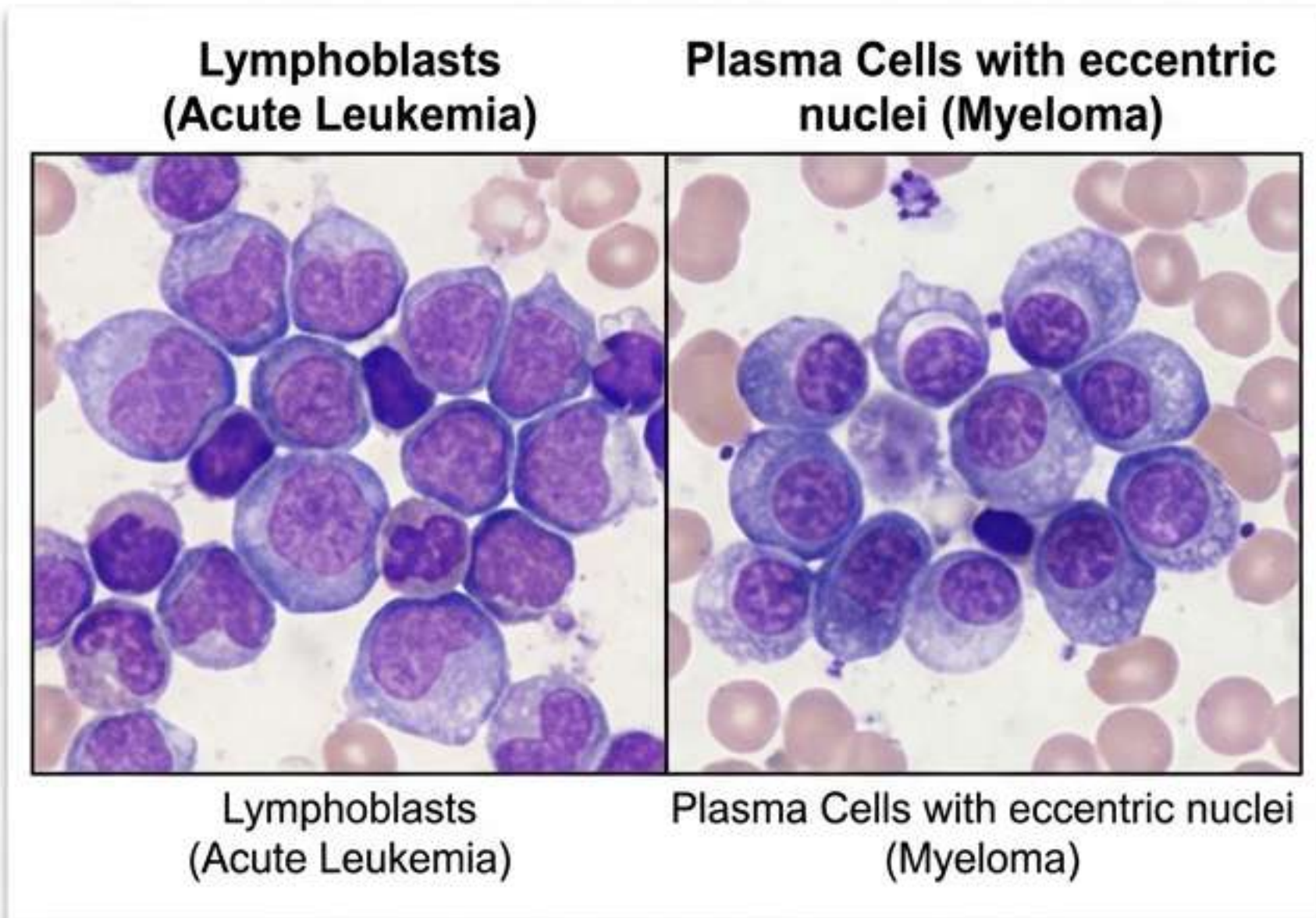
2. Chondrosarcomes

- Démographie : Tumeur du sujet adulte.
- Origine : Spontanée ou sur lésion préexistante (enchondrome).
- Localisation : Os plats (côtes, ceintures) ou métaphyse des os longs/maxillaires.
- Macroscopie : Aspect lobulé, nacré, bleuâtre.
- Microscopie : Tissu cartilagineux plus ou moins élaboré.
- Diagnostic : Difficile dans les formes très bien différenciées.



Chondrosarcome

Autres Tumeurs : Hémolymphatiques (1/2)



- **Généralités**

- **Distinction** : Tumeurs lymphoïdes solides (Lymphomes) vs. Liquides (Leucémies).

- **Leucémies & Syndromes**

- **Leucémies Aiguës Lymphoïdes** : Enfant et adulte jeune.
- **Leucémies Lymphoïdes Chroniques (LLC)** : Envahissement sanguin et médullaire (B ou T).
- **Maladie de Waldenström** : Avec pic monoclonal d'IgM sérique.
- **Autres** : Maladie des chaînes lourdes, Leucémie à tricholeucocytes.

- **Myélome**

- **Définition** : Tumeur plasmocytaire.
- **Localisation** : Osseuse.
- **Marqueur** : Pic monoclonal sérique (IgA, IgG).

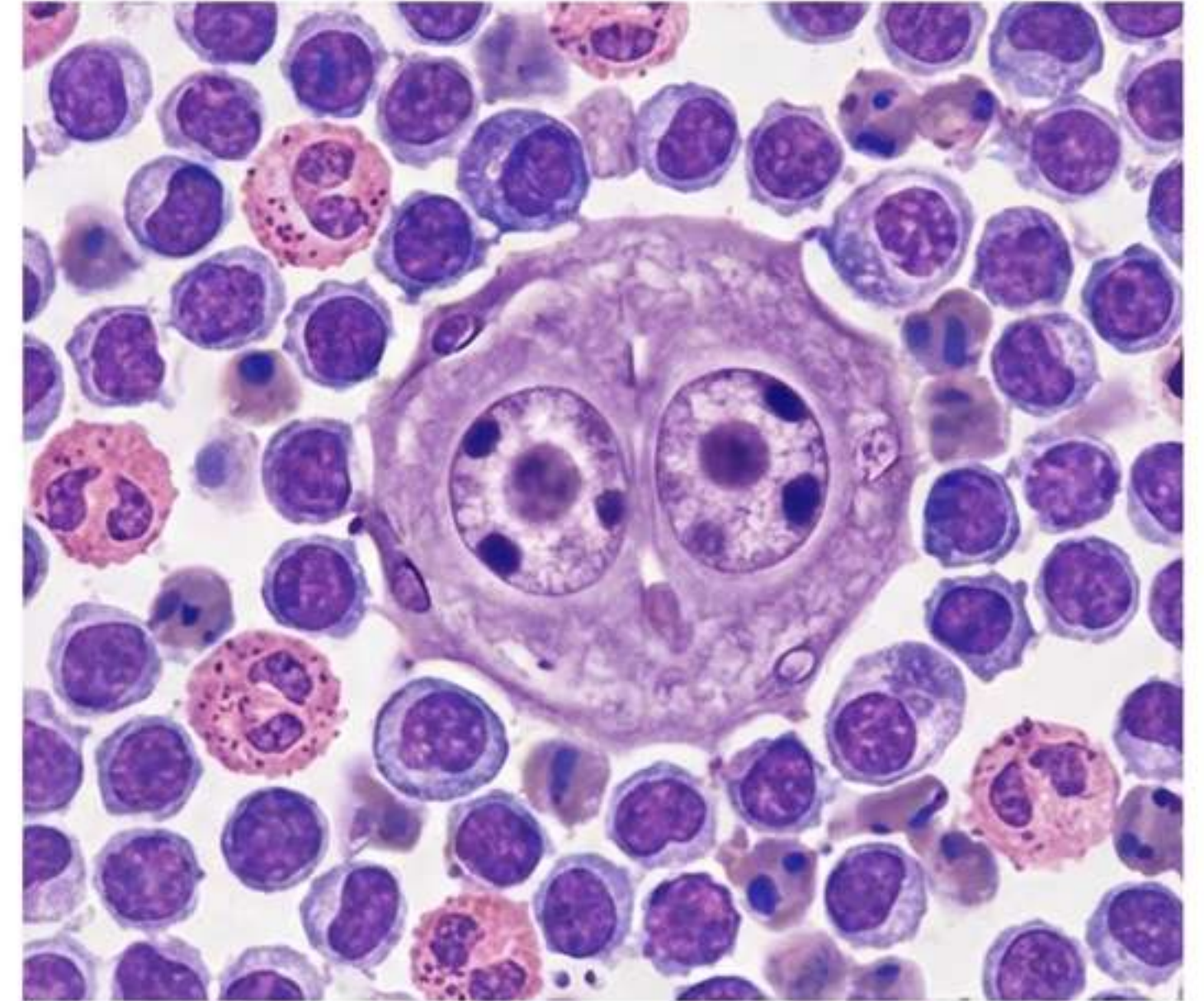
Autres Tumeurs : Hémolymphatiques (2/2)

Lymphomes Malins Non Hodgkiniens (LMNH)

- **Localisation** : N'importe quel territoire lymphoïde, muqueuses, thyroïde, glandes salivaires.
- **Classification** : Cytologique, architecturale, phénotypique, cytogénétique.

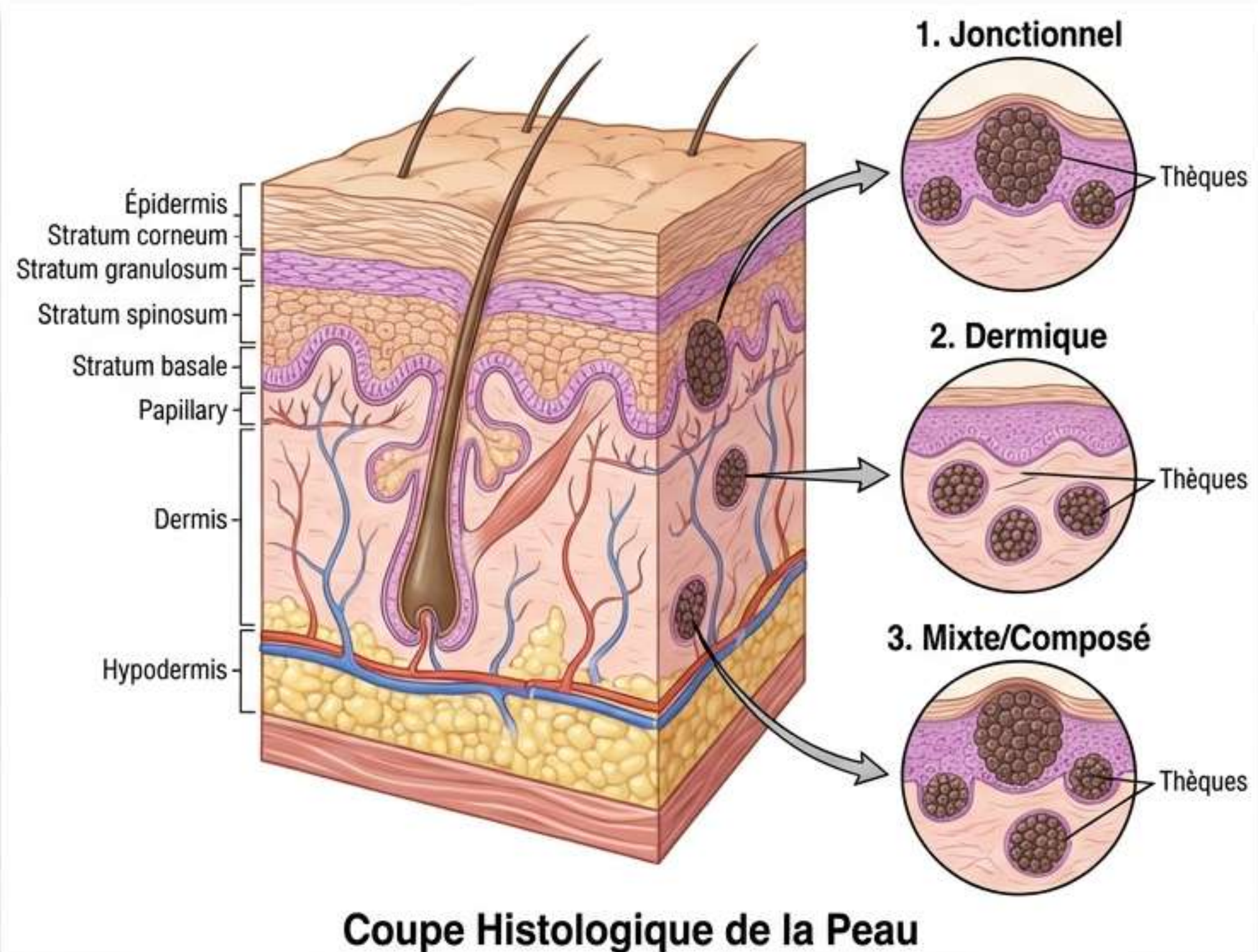
Lymphomes Malins Hodgkiniens

- **Caractéristiques** : Prolifération cellulaire polymorphe.
- **Cellule Clé** : Cellules de Sternberg (Pathognomoniques).
- **Environnement** : Lymphocytes, plasmocytes, éosinophiles, histiocytes.
- **Classification** : Classification de Lukes-Rye (4 types histologiques).



Reed-Sternberg Cell (Hodgkin Lymphoma)

Tumeurs Mélaniques (1/2) : Le Naevus



Le Naevus Naevo-Cellulaire

- **Origine** : Cellules élaborant le pigment mélanique (Peau, choroïde, muqueuses).
- **Structure** : Prolifération de cellules naeviques groupées en amas de 5 à 20 cellules appelés « Thèques ».

Classification

- **Naevus Jonctionnel** : Thèques au niveau de l'assise basale de l'épiderme.
- **Naevus Dermique** : Thèques situées dans le derme.
- **Naevus Mixte/Composé** : Aspects des deux précédents types.

Tumeurs Mélaniques (2/2) : Les Mélanomes

Généralités

- **Fréquence** : Tumeurs rares mais en progression constante.
- **Pronostic** : Particulièrement péjoratif.
- **Développement** : Sur naevus pré-existant ou peau saine (plus souvent).
- **Facteur de Risque** : Exposition au soleil pendant l'enfance et l'adolescence.

Évolution (2 Stades)

1. **Extension « Horizontale »** intra-épidermique.
2. **Extension « Verticale »** : Pénétration dans le derme, extension en profondeur et métastases.

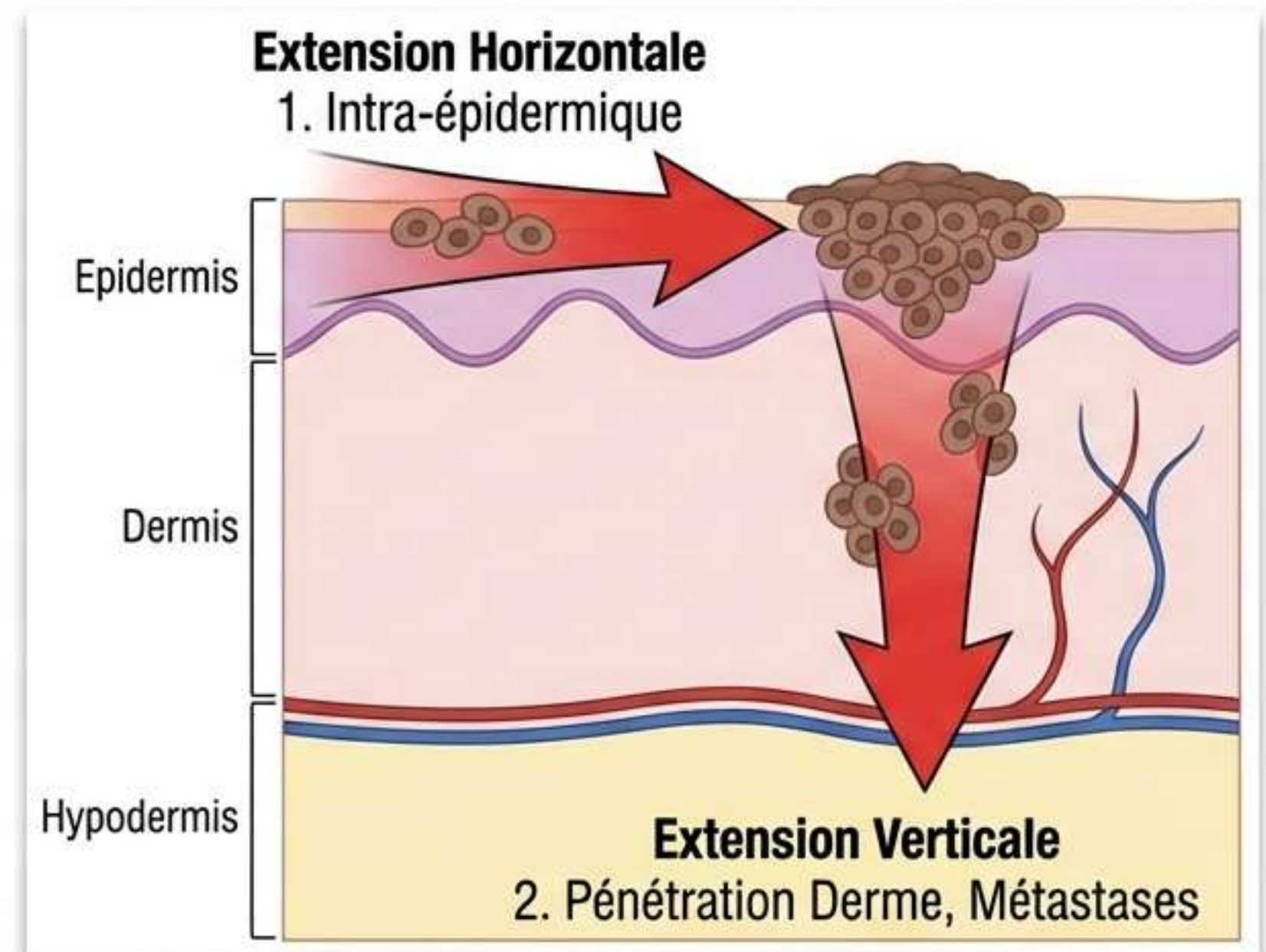
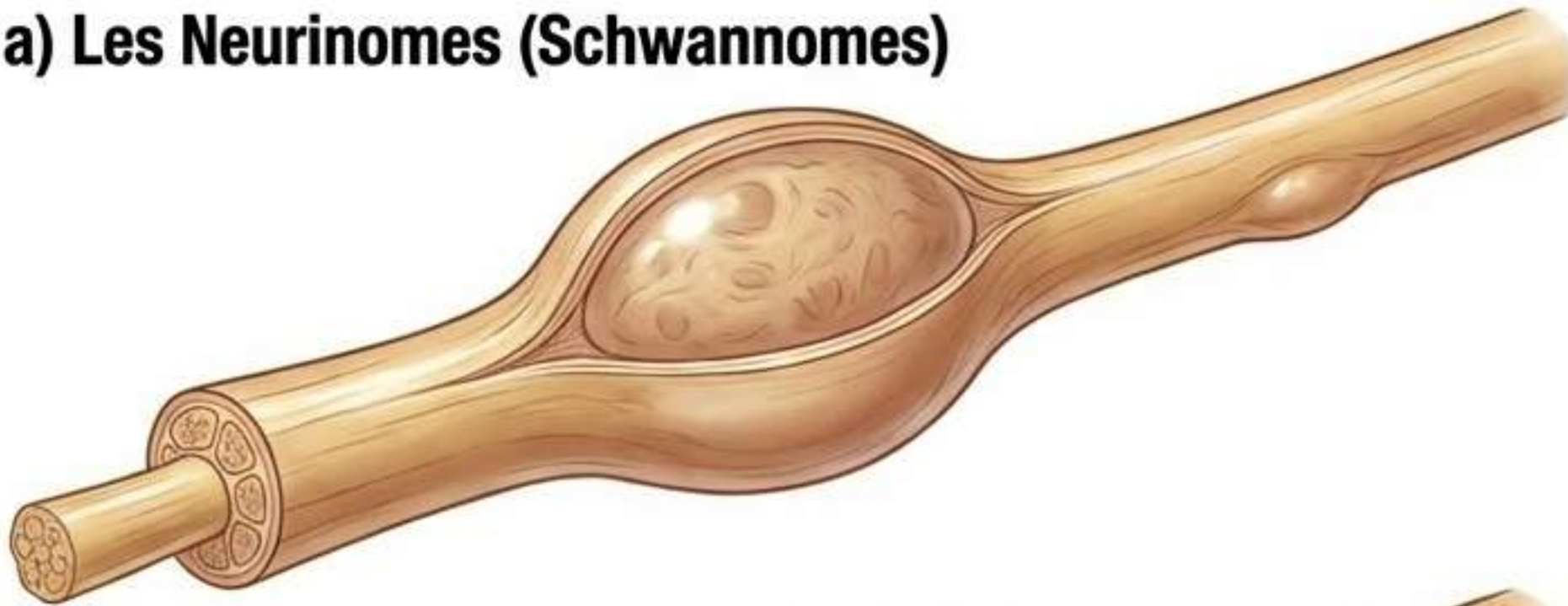


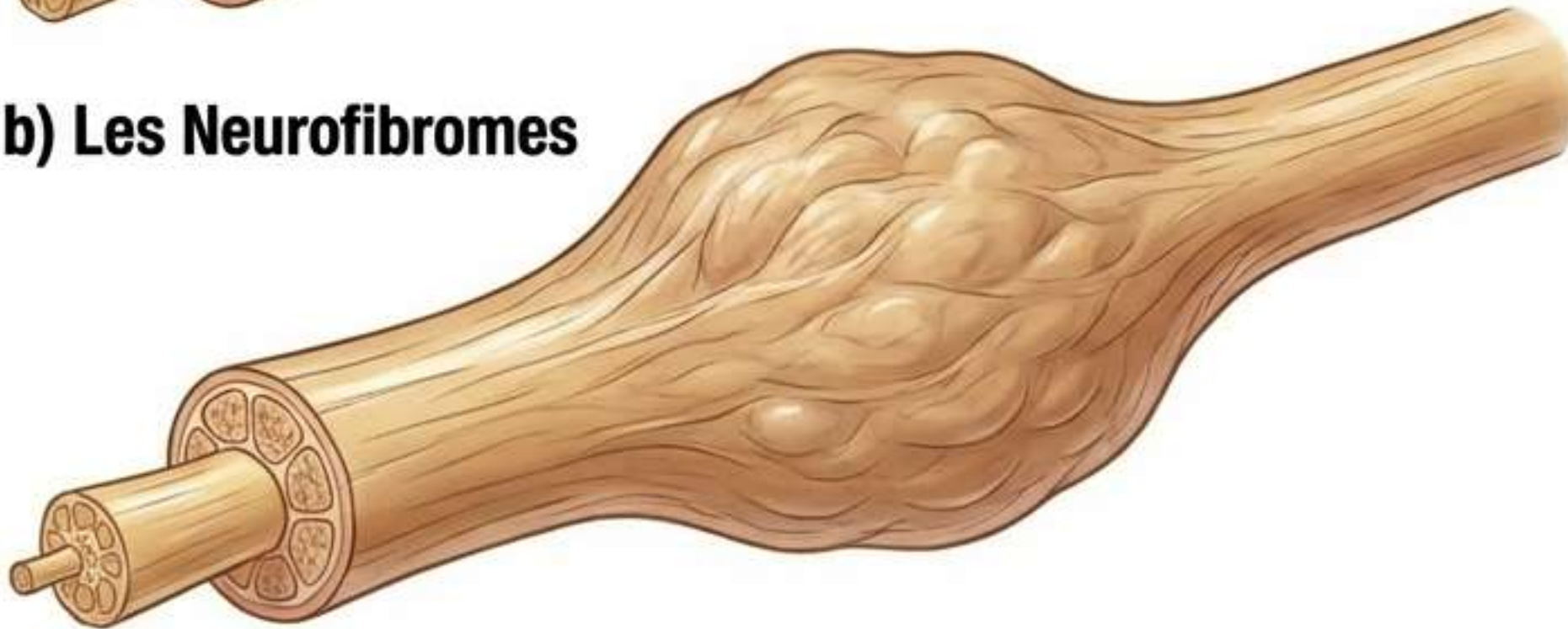
Schéma de Progression du Mélanome

Tumeurs du Système Nerveux

a) Les Neurinomes (Schwannomes)



b) Les Neurofibromes



a) Les Neurinomes (Schwannomes)

- **Origine** : Prolifération des cellules de Schwann de la gaine des nerfs.
- **Démographie** : Adulte d'âge moyen.
- **Caractéristiques** : Tumeurs encapsulées, appendues à un nerf.
- **Pronostic** : Bon après exérèse.

b) Les Neurofibromes

- **Composition** : Prolifération de cellules de Schwann + Cellules fibroblastiques + Fibres conjonctives.
- **Contexte** : Peuvent être multiples.
- **Pathologie** : S'intègrent au cadre des Neurofibromatoses.

Carte Mentale : Synthèse des Tumeurs

